ORACLE VAE AS

Au cœur du soin · Au service du diplôme

SIRET 100 107 739 00011 · 07 56 44 65 17 · oraclevaeas@outlook.fr

DOSSIER DE RÉFÉRENCE

Les valeurs, les protocoles et les mots que le jury attend · BC2 et BC4

Madame , née · remis avant la séance 2 · oral du 25 septembre 2026

Ce dossier ne remplace pas votre livret. Il rassemble, sur quelques pages, ce qui doit être su par cœur le jour de l'oral. Apprenez les chiffres. Le reste, vous le savez déjà : il s'agit surtout de le dire avec les bons mots.

1 — Les chiffres à connaître par cœur

Paramètre	Valeur normale, adulte	Anormal — les mots à employer
Glycémie à jeun	0,70 à 1,10 g/L	Hypoglycémie en dessous de 0,70 g/L. Hyperglycémie au-dessus de 1,26 g/L à jeun.
Fréquence respiratoire	12 à 20 par minute	Au-dessus de 20 : tachypnée. En dessous de 12 : bradypnée.
Fréquence cardiaque	60 à 100 battements par minute	Au-dessus de 100 : tachycardie. En dessous de 60 : bradycardie.
Tension artérielle	Environ 120/80 mmHg	Hypertension à partir de 140/90. Hypotension en dessous de 90/60.
Température	36,5 à 37,5 °C	Fièvre à partir de 38 °C. Hypothermie en dessous de 35 °C.
Saturation en oxygène	95 % ou plus	Désaturation en dessous de 95 %. Seuil plus bas toléré chez un insuffisant respiratoire connu.
Diurèse sur 24 heures	1 à 1,5 litre	Oligurie en dessous de 500 mL. Anurie en dessous de 100 mL. Polyurie au-delà de 2,5 litres.

Deux valeurs vous ont été reprochées à l'oral de septembre 2025 : la diurèse et les signes d'hyperglycémie. Ce sont les deux premières à apprendre.

2 — Hypoglycémie : la conduite à tenir

Reconnaître

Sueurs, pâleur, tremblements, faim brutale, palpitations, vertiges, troubles du comportement, confusion, vision trouble. Si rien n'est fait : perte de connaissance, convulsions, coma.

Comprendre — la phrase qui vaut les points

Chez une personne diabétique traitée, le traitement continue d'agir même quand la personne ne mange pas. Apports insuffisants et traitement maintenu, c'est le mécanisme même de l'hypoglycémie.

Agir — personne consciente et capable d'avaler

	Ce que je fais	Pourquoi
1	Je mets la personne en sécurité : je l'assois ou je l'allonge, je ne la laisse pas debout	Le risque immédiat est la chute
2	J'alerte l'infirmière	L'évaluation et la décision lui reviennent

3	Je réalise la glycémie capillaire sur sa demande	Acte réalisé en collaboration, dans mon champ
4	Je donne 15 g de sucre rapide : 3 morceaux de sucre, ou un petit verre de jus de fruit d'environ 125 mL, ou une cuillère à soupe de miel ou de confiture	Absorption immédiate
5	Je recontrôle 15 minutes après. Si c'est encore bas, je renouvelle	Vérifier l'efficacité du resucrage
6	Puis un sucre lent — pain, biscotte — si le repas est éloigné	Éviter la rechute
7	Je reste auprès d'elle et je surveille : conscience, coloration, sueurs, comportement, reprise alimentaire	La récidive est le risque le plus oublié
8	Je transmets à l'oral et je trace sur le dossier informatisé	Continuité et traçabilité des soins

Agir — personne inconsciente ou qui ne peut pas avaler

- Rien par la bouche. Aucun aliment, aucune boisson.
- Position latérale de sécurité si elle est inconsciente et respire.
- Alerte immédiate de l'infirmière ou du médecin. Je ne quitte pas la personne.

Le chocolat

Il n'est pas adapté : les matières grasses ralentissent l'absorption du sucre, l'effet arrive trop tard. Si le jury vous interroge sur ce point, la bonne réponse est simple et se dit sans embarras : « En reprenant mon dossier, j'ai revu ce point. Aujourd'hui je donnerais 15 g de sucre rapide. Ma démarche était juste — mise en sécurité, alerte, contrôle à 15 minutes — c'est le produit qui ne l'était pas. »

3 — Hyperglycémie

Soif intense, urines abondantes et fréquentes, bouche sèche, fatigue, amaigrissement, vision trouble, nausées. Dans l'acidocétose : douleurs abdominales, respiration ample et rapide, haleine à odeur de pomme.

Ce que je fais : je fais boire de l'eau, j'alerte l'infirmière, je réalise la glycémie sur sa demande, je surveille l'état de conscience et je transmets.

La rougeur du visage n'est pas un signe d'hyperglycémie. C'est la réponse qui vous a été reprochée en 2025 : remplacez-la par soif et urines abondantes.

4 — Surveiller un résident diabétique au quotidien

- La prise réelle des repas, à chaque repas — c'est le point de départ de votre situation.
- Les glycémies aux horaires prescrits, et leur traçabilité.
- L'état des pieds et de la peau : le diabète abîme les nerfs et les vaisseaux, une plaie peut passer inaperçue.
- L'hydratation, le poids, l'état général.
- Les signes d'hypoglycémie et d'hyperglycémie.
- La prise effective du traitement, et je transmets tout écart.

5 — L'escarre : repérer, prévenir, évaluer

Les échelles de risque

Échelle	Ce qu'elle mesure	À retenir

Braden	6 critères : perception sensorielle, humidité, activité, mobilité, nutrition, frottement et cisaillement	Score de 6 à 23. Plus le score est bas, plus le risque est élevé. Risque à partir de 18 et en dessous.
Norton	5 critères : état physique, état mental, activité, mobilité, incontinence	Score de 5 à 20. Risque à partir de 14 et en dessous.

Vous n'avez pas à calculer le score : c'est l'infirmière qui l'établit. Mais vous devez savoir que ces échelles existent, les nommer, et dire que vous participez au recueil des éléments.

Les stades de l'escarre

Stade	Ce que l'on voit
1	Rougeur qui ne blanchit pas à la pression du doigt. La peau est intacte. C'est le stade où tout est encore réversible.
2	Atteinte superficielle : phlyctène — une cloque — ou perte d'épiderme.
3	Atteinte de toute l'épaisseur de la peau, jusqu'au tissu graisseux.
4	Atteinte profonde : muscle, tendon ou os visible.

Les points d'appui à examiner

Sacrum, talons, trochanters — les hanches, ischions — les fesses en position assise, coudes, omoplates, occiput, oreilles, et les orteils. Chez une personne alitée, l'observation se fait à chaque toilette.

Prévenir — ce que je fais, moi, aide-soignante

- Changements de position réguliers, environ toutes les deux à trois heures, et je trace les positions.
- Supports de décharge : matelas et coussins adaptés, cales, talonnières. Je ne laisse pas les talons reposer sur le matelas.
- Hygiène et séchage soigneux, lutte contre la macération : changes, literie sèche, pas de plis dans les draps.
- Hydratation de la peau. Je ne masse jamais une rougeur : le massage aggrave la lésion.
- Surveillance des apports alimentaires et de l'hydratation : la dénutrition favorise l'escarre.
- Mobilisation et lever dès que l'état le permet.
- Observation quotidienne des points d'appui, et transmission de toute rougeur.

6 — Évaluer la douleur chez une personne qui ne peut pas la dire

Échelle	Pour qui	Comment
EVA, EN ou EVS	Personne qui communique	Elle situe elle-même sa douleur : de 0 à 10, ou sur une réglette, ou avec des mots — nulle, faible, modérée, intense.
Algoplus	Personne âgée non communicante — douleur aiguë	5 items observés : visage, regard, plaintes, corps, comportements. Un score de 2 sur 5 ou plus signe la douleur.
Doloplus-2	Personne âgée non communicante — douleur chronique	10 items sur 3 domaines : retentissement somatique, psychomoteur, psychosocial. Un score de 5 sur 30 ou plus signe la douleur.

La formulation attendue : « Elle ne pouvait pas me dire qu'elle avait mal, alors je l'ai évaluée avec une échelle d'hétéro-évaluation. J'ai observé son visage, ses plaintes, la position de son corps, sa réaction à la mobilisation. J'ai transmis à l'infirmière et je l'ai tracé. »

7 — Le bio-nettoyage — bloc 4

Le rapport de jury de septembre 2025 est explicite : « bio-nettoyage pas maîtrisé, pas d'interrupteur, pulvérise directement la surface, nettoyage du WC non protocolaire, pas de traçabilité des évènements indésirables ». C'est le bloc à reconstruire entièrement.

Le produit : le détergent-désinfectant

- Détergent : il décolle et enlève les salissures. Désinfectant : il détruit les micro-organismes. Le détergent-désinfectant fait les deux en une seule opération.
- Je respecte la dilution indiquée par le fabricant. Trop dilué, il n'agit pas ; trop concentré, il abîme les surfaces et n'est pas plus efficace.
- Je respecte le temps de contact indiqué sur la fiche technique : le produit doit rester sur la surface pour agir. C'est le point que l'on oublie le plus souvent.
- Je prépare la solution au moment de l'emploi, dans un contenant propre et identifié, et je ne mélange jamais deux produits.
- Je porte des gants, et je consulte la fiche technique et la fiche de données de sécurité disponibles dans le service.

Le geste — la correction attendue

Je ne pulvérise pas directement sur la surface. Je pulvérise sur la lavette, ou j'imprègne la lavette, puis j'essuie. Pulvériser sur la surface met le produit en suspension dans l'air : c'est un risque respiratoire pour le résident et pour moi, et cela disperse les germes.

- Je vais du plus propre vers le plus sale, et du haut vers le bas.
- Je ne repasse jamais sur une zone déjà nettoyée : un seul passage, sans retour en arrière.
- Je change de lavette par zone et par niveau de propreté. Le sol se fait en dernier.
- Le WC se fait en dernier, avec un matériel dédié et repéré, jamais celui du lavabo.

Les points de contact à ne jamais oublier

Interrupteur, sonnette, télécommande, poignées de porte et de fenêtre, barres d'appui, potence et barrières du lit, télécommande du lit, adaptable, robinetterie, chasse d'eau, accoudoirs du fauteuil, déambulateur. Ce sont les surfaces les plus touchées, donc les plus contaminées.

Le bio-nettoyage de sortie — la chambre après un départ

	Étape	Point clé
1	Je m'équipe : tenue, gants, et je prépare mon matériel propre	Hygiène des mains avant et après, et à chaque changement de gants
2	J'évacue le linge sale et les déchets selon les circuits	Sacs fermés, jamais posés au sol, circuits du propre et du sale non croisés
3	Je retire tout ce qui est à usage unique et le matériel personnel restant	Rien ne reste d'un résident à l'autre
4	Je nettoie et désinfecte le mobilier : lit démonté, matelas sur ses deux faces, barrières, potence, table de nuit dedans et dehors, adaptable, fauteuil, placard, poignées	Du haut vers le bas, du propre vers le sale
5	Je fais les points de contact : interrupteur, sonnette, télécommandes, poignées	L'oubli signalé par le jury
6	Je fais la salle de bain, puis le WC en dernier, avec le matériel dédié	Lavabo, robinetterie, douche, barres d'appui, puis cuvette
7	Je fais le sol en dernier, de la zone la plus éloignée vers la porte	Je ne marche pas sur ce que je viens de nettoyer
8	J'aère, je referme, je fais la réfection du lit avec du linge propre	La chambre est prête pour l'entrée suivante
9	Je trace : fiche de bio-nettoyage datée et signée	Ce qui n'est pas tracé n'est pas fait

Les circuits

- DASRI, sac jaune : tout ce qui est souillé de sang ou de liquide biologique, et le matériel piquant ou coupant dans un collecteur adapté.
- DAOM, sac noir ou gris : les déchets ménagers, protections non souillées de liquides biologiques selon le protocole de l'établissement.
- Le linge sale ne croise jamais le linge propre, ni dans le chariot, ni dans le couloir.

8 — La fiche d'événement indésirable

Le jury vous a reproché l'absence de traçabilité des événements indésirables. C'est un point simple à récupérer, parce qu'il se raconte en quelques phrases.

Qu'est-ce qu'un événement indésirable

Tout fait qui a nui, ou qui aurait pu nuire, à un résident, à un professionnel ou au fonctionnement du service : une chute, une erreur de médicament, un défaut de matériel, une brûlure, une fugue, un acte de violence, un dysfonctionnement d'organisation. Le presque-accident se déclare aussi.

Ce que je remplis

- Qui : la personne concernée, et moi comme déclarante.
- Quoi : les faits, décrits sans jugement et sans interprétation.
- Quand et où : date, heure, lieu précis.
- Les conséquences constatées pour la personne.
- Les mesures immédiates que j'ai prises, et qui j'ai alerté.

Ce que j'en fais

Je transmets la fiche à l'infirmière et au cadre, selon la procédure de l'établissement. Elle est analysée par le référent qualité ou le gestionnaire des risques. La démarche n'est pas punitive : elle sert à comprendre et à éviter que cela se reproduise. Elle s'inscrit dans la démarche qualité et l'amélioration continue.

Si l'événement concerne un dispositif médical — un lève-personne, un lit, une barrière — je le signale aussi au titre de la matériovigilance, et je mets le matériel de côté pour qu'il ne soit pas réutilisé.

9 — Manutention et transfert

Le rapport 2025 note que vous avez expliqué à deux reprises porter seule la résidente. C'est la phrase à ne plus jamais prononcer, parce qu'elle met en danger le résident et vous-même.

La formulation à retenir : « Je sollicite ses capacités restantes, je l'accompagne avec les aides techniques, je ne la porte pas. »

- J'évalue d'abord ce que la personne peut faire elle-même, et je la fais participer : c'est aussi du maintien de l'autonomie.
- J'utilise les aides techniques : drap de glisse, disque de transfert, planche de transfert, verticalisateur, lève-personne, barres d'appui.
- Je fais appel à un collègue quand le transfert le demande. Un transfert prévu à deux ne se fait jamais seule.
- Je prépare : lit à bonne hauteur, freins mis, espace dégagé, chaussage adapté.
- Je me place : pieds écartés, genoux fléchis, dos droit, charge près du corps, pas de torsion du tronc.
- Je préviens la personne, je lui explique, et je compte avec elle avant de bouger.
- Si la personne est au sol, je ne la relève pas seule : je sécurise, j'évalue, j'alerte, je reste auprès d'elle, et je déclare la chute.

10 — Les quatre phrases à savoir dire

	La phrase
1	« J'ai observé…, j'en ai déduit…, donc j'ai fait…, et j'ai transmis… » — c'est l'ossature de toute réponse.
2	« Cet acte, je l'ai réalisé sur demande de l'infirmière, dans le cadre de la collaboration. L'évaluation et la décision lui reviennent. »
3	« Je sollicite ses capacités restantes, je l'accompagne avec les aides techniques, je ne la porte pas. »
4	« Je l'ai transmis à l'oral aux transmissions et je l'ai tracé dans le dossier informatisé. Ce qui n'est pas tracé n'est pas fait. »

Ce document est personnel et confidentiel. Il est établi dans le cadre du contrat d'accompagnement signé entre vous et ORACLE VAE AS, et ne peut être communiqué à un tiers.